

골다공증 약과 치과 시술, 약을 꼭받는 것이 답이 아닙니다

필요한 치과 치료를 미루는 것이 오히려 위험할 수 있습니다 — 가장 중요한 것은 약 이름과
마지막 주사 날짜입니다

골다공증 약과 치과 시술, 약을 끊는 것이 답이 아닙니다

필요한 치과 치료를 미루는 것이 오히려 위험할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 드시는 약의 이름과 마지막 주사 날짜입니다.

☰ 이 데에서 다루는 것

- 1 약 이름
- 2 얼마나 드문가
- 3 발치 시점
- 4 치과에 알릴 것

골다공증약을 먹으면 치과 치료를 못 하나요?

아닙니다. 필요한 치과 치료를 미루는 것이 오히려 더 위험합니다

☰ 대부분의 치과 치료는 가능합니다

골다공증 용량으로 먹는 약이나 프롤리아를 쓰는 분에서 턱뼈 문제가 생기는 일은 **드물다**습니다. 스케일링·충치 치료·신경 치료처럼 뼈를 건드리지 않는 치료는 약을 조정할 필요도 없습니다.

🔍 미루면 더 위험합니다

잇몸 염증이나 뿌리 끝 감염을 그대로 두는 것이 오히려 턱뼈 문제를 키웁니다. 실제로 턱뼈 문제가 생긴 분들에서는 **이미 깊은 이를 뽑은 일**이 앞선 경우가 많았습니다. 약이 무서워 치과를 미루지 마시고, 약 이름을 들고 가십시오.

2~5

먹는 골다공증약을 쓰는 1만 명 가운데 턱뼈 문제가 생기는 사람 수

- 1 필요한 치과 치료는 받습니다
- 2 약은 스스로 끊지 않습니다
- 3 약 이름부터 확인합니다

Tip · 치과 예약이 잡히면 먼저 내과에 알려 주십시오. 약 종류에 따라 시점을 함께 맞추면 됩니다.

가장 중요한 건 '약 이름'입니다

먹는 약 · 프롤리아 · 암 치료용 주사 — 셋은 완전히 다릅니다

▲ ① 먹는 골다공증약

알렌드로네이트 같은 먹는 약입니다. 턱뼈 문제는 **1만 명당 2~5명** 수준입니다.

■ ② 프롤리아(6개월 주사)

1만 명당 4~30명. 더 중요한 건 오래 미루면 척추가 무너질 수 있다는 점.

■ ③ 암 치료용 주사

100명 중 1~15명에서 생깁니다 — 골다공증 용량보다 **100~1,000배** 높습니다.

3가지

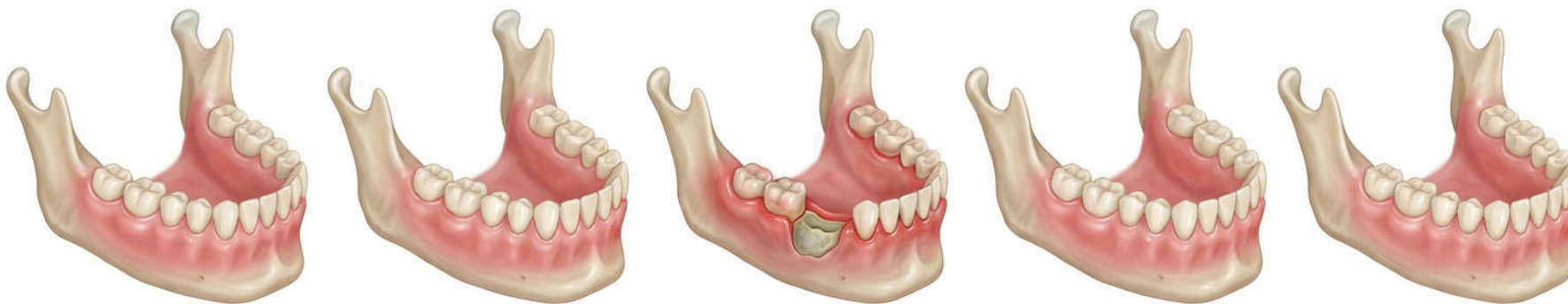
약 이름부터 확인합니다

- 1 ① 먹는 약
- 2 ② 프롤리아 주사
- 3 ③ 암 치료용 고용량 주사 — 다른 이야기

Tip · 치과에서 물으면 약봉투나 처방전을 그대로 보여 주는 것이 가장 정확합니다.

다른 약은 하나입니다

다섯 칸 중 턱뼈 문제가 그려진 칸은 하나뿐입니다



왼쪽부터 ①먹는 약 ②1년에 한 번 맞는 주사 ③프롤리아 ④로모소주맙 ⑤테리파라타이드. 표시된 칸은 ⑤ 하나입니다. 설명용 그림입니다.

턱뼈 괴사가 무엇인가요

잇몸이 아물지 않고 뼈가 드러난 상태를 말합니다

⚠ 세 가지 조건

① 골다공증약·항암 주사를 쓴 적이 있고 ② 턱뼈가 **8주** 넘게 드러나 있고 ③ 턱 방사선 치료력 없음.

≡ 드문 일입니다

골다공증 용량에서는 드물게 생깁니다. 다만 암 치료용 고용량 주사를 맞는 분들에서는 훨씬 흔합니다.

➡ 이럴 때 진료

이를 뽑은 자리가 몇 주가 지나도 낫지 않거나, 턱이 계속 아프고 뼈가 만져지면 치과 진료를 받으세요.



이를 뽑은 자리가 아물지 않고 뼈가 드러난 모습 — 8주 넘게 이 상태가 이어지면 턱뼈 괴사로 봅니다.

Tip · 뼈가 보이지 않아도 턱이 계속 아프면 한 번 확인해 보세요.

얼마나 드문가 — 1만 명을 세어 봅니다

먹는 약은 1만 명당 2~5명, 프롤리아는 4~30명으로 보고됩니다

🔍 먹는 약

1만 명당 2~5명입니다. 약을 쓰지 않은 분들(1만 명당 0~2명)과 겹칠 만큼 낮은 숫자입니다.

☰ 프롤리아

1만 명당 4~30명으로 먹는 약보다는 높습니다. 10년 넘게 쓴 분들을 모아 본 값이라 기간이 긴 숫자입니다.

▲ 이를 뽑아야 할 때는

이를 뽑는 분들만 따로 모으면 숫자가 올라갑니다. 프롤리아를 맞으며 발치한 427명 중 **10명(2.3%)**에서 턱뼈 문제가 생겼습니다. 전체 위험과는 다릅니다.

2~5

먹는 골다공증약 1만 명당 생기는 수 · 프롤리아는 4~30명

- 1 먹는 약 — 2~5명
- 2 프롤리아 — 4~30명
- 3 암 주사 — 훨씬 높음

Tip · 연구마다 세는 기간과 방법이 달라, 이 숫자들끼리 곧바로 견주지는 않습니다.

암 치료용 주사는 다릅니다

같은 약 이름이어도 용량이 다르면 완전히 다른 이야기

▲ 골다공증 용량과 암 용량

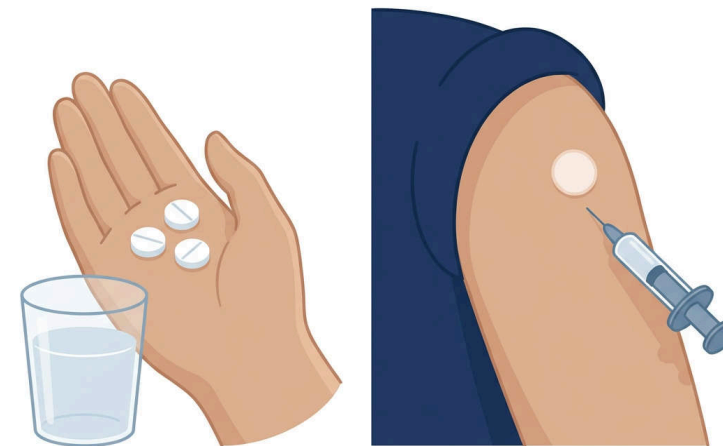
골다공증에 쓰는 프롤리아는 6개월마다 **60mg**, 암 뼈전이에 쓰는 주사는 4주마다 **120mg**입니다. 누적 노출량이 수십 배가 됩니다.

🔍 턱뼈 위험은 얼마나 다른가

암 치료를 받는 분들에서는 100명 중 1~15명입니다 — 골다공증 용량보다 **100~1,000배** 높습니다.

— 그래서 이렇게 하십시오

암 치료로 뼈 주사를 맞고 계시면 치과 치료 전에 담당 주치의와 먼저 상의하십시오.



먹는 약과 주사는 서로 다른 약입니다 — 치과에 가실 때 어느 쪽을 쓰는지 꼭 알려 주세요.

Tip · 암 치료로 뼈 주사를 맞는 분은 이 자료의 숫자를 그대로 적용하지 마십시오.

위험을 높이는 것 — 대부분 '감염'입니다

약보다 입안 상태가 더 큰 몫을 합니다

가장 큰 계기는 발치

턱뼈 문제가 생긴 분들을 되짚어 보면 이를 뽑은 일이 앞선 경우가 **62~82%**로 가장 많았습니다. 다만 이미 감염된 이였던 탓도 큼니다.

입안에서 살펴볼 것

잇몸병(치주염) · 뿌리 끝 곪음 · 임플란트 주위 염증 · 안 맞는 틀니가 잇몸을 계속 헐게 하는 것.

몸 쪽에서 겹치는 것

스테로이드를 오래 쓰는 경우, 당뇨, 콩팥병, 흡연, 고령이 겹치면 상처가 더디 아뒹니다.

감염

뽑는 것보다, 곪은 이를 그대로 두는 쪽이 더 문제입니다

1 잇몸병·뿌리 끝 감염

2 안 맞는 틀니 — 조정

3 당뇨·흡연

Tip · 치과 치료를 피하려고 곪은 이를 두는 것이 가장 나쁜 선택입니다.

먹는 약은 발치 때문에 끊지 않습니다

2~3개월 쉬어도 약은 이미 뼈에 남아 있어, 끊는 이득이 확인되지 않았습니다

▲ 왜 끊어도 소용이 적은가

먹는 골다공증약은 뼈에 달라붙어 **수년** 동안 남습니다. 그래서 두세 달 쉬다고 뼈 안의 약이 빠지지는 않습니다.

● 연구로 확인된 것

약을 쉬는 분들과 그대로 드신 분들에서 차이가 **확인되지 않았습니다**.

● 쉬는 쪽이 오히려 손해

약을 쉬는 동안 골절을 막는 힘은 줄어듭니다. 스스로 끊지 마십시오.

수년

먹는 약이 뼈에 남아 있는 기간 — 그대로입니다

- 1 먹는 약 — 계속 복용
- 2 치과에는 약 이름 전달
- 3 2개월 휴약 여부는 의사가 정합니다

Tip · 치과에서 '몇 달 끊고 오세요' 라고 하면, 약 이름부터 알려 주십시오.

프롤리아는 다릅니다 — 미루면 위험

오래 미루면 척추뼈 골절이 한꺼번에 몰려서 옵니다

⚠ 먹는 약과 무엇이 다른가

프롤리아는 뼈에 쌓이지 않고 몸에서 빠져나갑니다. 그래서 주사가 늦어지면 **반동**이 옵니다.

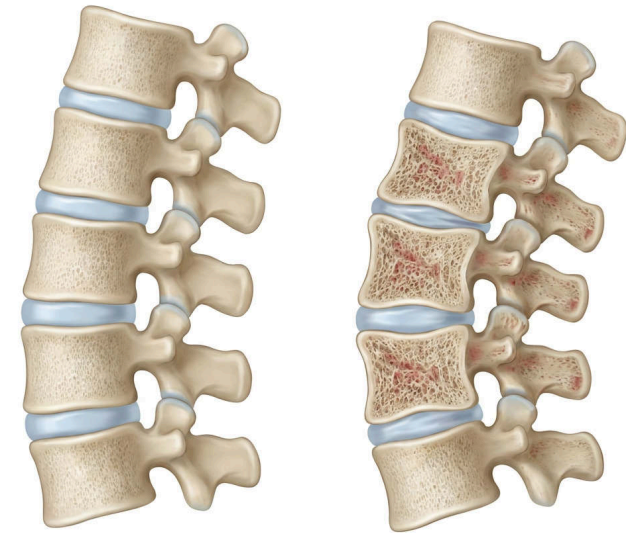
≡ 숫자로 보면

주사를 끊으면 척추 골절이 100명당 1년에 **1.2건에서 7.1건**으로 늘었습니다. 그중 61%가 여러 마디였습니다.

— 특히 조심

이미 척추 골절을 겪은 적이 있으면 여러 마디가 함께 무너질 위험이 약 **3.9배**였습니다.

Tip · 프롤리아는 '끊는 약'이 아니라 '시점을 맞추는 약'입니다.



주사를 오래 미룬 뒤의 척추 — 왼쪽에 견주어 오른쪽은 여러 마디가 납작하게 내려앉고 등이 굽었습니다. 설명용 일러스트.

발치는 마지막 주사 3~4개월 뒤

계획할 수 있다면 이 구간이 가장 무난합니다

— 왜 이때인가

주사 힘이 한풀 꺾여 잘 아물고, 아직 반동이 올 시기는 아니기 때문입니다.

— 지났다면

마지막 주사가 이미 **5개월** 전이라면 더 기다리지 말고 지금 뽑는 편이 낫습니다. 기다릴수록 골절 쪽 시계만 갑니다.

⚠ 급할 때는

많이 아프거나 굼은 이라면 시점을 따지지 말고 바로 치료합니다. 감염을 두는 쪽이 더 나쁩니다.

3~4

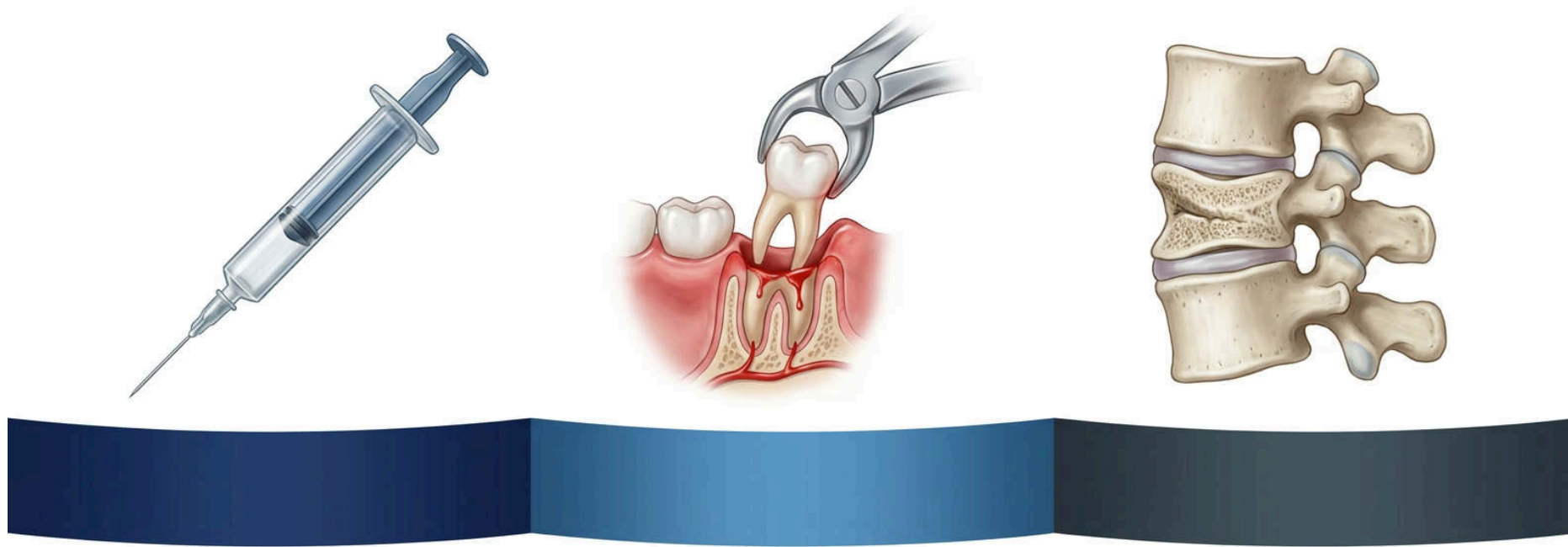
마지막 주사 뒤 이 구간이 가장 무난합니다

- 1 3~4개월 뒤
- 2 5개월 지났으면 미루지 않는다
- 3 아프거나 굼았으면 바로

Tip · 진료 때 마지막 주사 날짜를 꼭 확인해 주십시오. 그 날짜 하나로 계획이 정해집니다.

시기가 중요합니다

주사와 주사 사이를 왼쪽에서 오른쪽으로 펼친 그림입니다



왼쪽 = 주사를 맞은 직후, 가운데 = 이를 뽑기 좋은 시기, 오른쪽 = 너무 미웠을 때 척추가 내려앉는 시기입니다.

발치 후 다음 주사는 언제 — 잇몸이 아물면

뼈가 다 찌할 때까지 기다리지 않습니다

기준은 잇몸

뼈는 자리를 잇몸이 안정적으로 덮으면 됩니다. 보통 **6~8주** 걸립니다.

왜 뼈를 기다리지 않나

뼈가 다 차려면 몇 달이 걸립니다. 그때까지 미루면 주사 간격이 너무 벌어집니다.

넘기지 말 선

6개월 정시가 목표이고, **7개월**은 넘기지 않는 것이 실무 기준입니다. 권고안의 마지막 한계선은 총 **9개월**입니다.

잇몸

다음 주사의 기준은 잇몸 — 보통 6~8주

- 1 발치 → 잇몸 아물
- 2 다음 주사
- 3 총 9개월 넘기지 않기

Tip · 치과에서 '뼈가 다 찌할 때까지 주사 맞지 마세요' 라고 하면 내과에 알려 주세요.

임플란트, 되나요 — 대부분 가능합니다

골다공증 용량에서는 절대 안 되는 시술이 아닙니다

— 약을 끊고 해야 하나요

골다공증 용량이라면 약을 끊지 않고도 심을 수 있다고 봅니다.

— 숫자로

먹는 약을 오래 쓴 분들에서 임플란트 뒤 턱뼈 문제는 **1,000명당 3명** 정도로 보고됐고, 프롤리아에서는 **0.5%** 정도로 보고됐습니다.

⚠ 그래도 확인할 것

잇몸병·당뇨·스테로이드가 있으면 미리 정리하고 시작합니다. 암 치료용 고용량 주사를 맞는 분은 이야기가 다릅니다.

3명

먹는 약 장기 복용 · 임플란트 뒤 1,000명당

- 1 절대 금기 아님
- 2 잇몸병·당뇨는 미리 정리
- 3 암 치료용 고용량은 별개

Tip · 임플란트가 잘 붙는가와 턱뼈 문제가 생기는가는 서로 다른 이야기입니다.

CTX 검사, 되나요

결론부터 — 아니요

어떤 검사인가요

뼈가 얼마나 활발히 바뀌는지 보는 피검사입니다. 예전에 이 수치로 발치 시점을 정하자는 제안이 있었습니다.

지금은 권하지 않습니다

이 수치의 정확도가 낮았습니다 — 맞힌 비율 약 **34%**.

그럼 무엇을 보나

약 이름·마지막 주사일·입안 상태가 더 중요합니다.

34

% — 위험한 분을 맞힌 비율

1 CTX 기준 — 미검증

2 약 이름부터

3 마지막 주사

Tip · 검사 숫자 하나로 안전한 날을 정하지는 않습니다.

치과에 꼭 알려 주세요 — 네 가지면 됩니다

이 네 가지만 정확히 전하면 치과가 판단할 수 있습니다

① 약 이름

'골다공증약'이라고만 하지 마시고 **정확한 이름**을 알려 주세요. 약봉투나 처방전을 그대로 보여 주시면 정확합니다.

② 마지막 주사일

프로리아처럼 6개월마다 맞는 주사는 **마지막 날짜**가 계획의 출발점입니다. 몇 월 며칠에 맞았는지 확인해 두십시오.

③ 치료 기간

언제부터 얼마나 오래 드셨는지, 중간에 바꾼 약이 있는지도 함께 알려 주세요.

4가지

약 이름 · 마지막 주사일 · 치료 기간 · 암 치료용인지

1 약 이름·제형(먹는약/주사)

2 마지막 주사 날짜

3 ④ 암 치료용인지 골다공증용인지

Tip · '주사 맞아요' 만으로는 골다공증용과 암 치료용이 구분되지 않습니다.

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

골다공증 치료 중 치과 치료를 앞둔 분들을 위한 설명자료입니다. 숫자는 진료실에서 참고하는 자료를 바탕으로 했고, 실제 치료 시점과 약 조정은 담당 의사·치과와 상의해 정합니다.



SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다